मातृ तथा बाल स्वास्थ्य

नेपालजस्ता कम स्रोत र भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण परिवेशमा ढिलो उपचार खोज्ने, सामुदायिक स्तरमा सीमित क्लिनिकल विशेषज्ञता र फ्राकमेन्टेड रेफर पथका कारण आमा र बच्चाको स्वास्थ्य परिणाम सीमित रहन्छ, जसका कारण प्रायः रोकथाम योग्य अवस्थालाई जीवन घातक आपतकालिन अवस्थामा परिणत गराइन्छ । नेपालमा ५२ हजार महिला सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी छन् ।

हामी फ्रन्टलाइन सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेषगरी डिजाइन गरिएको अफलाइन प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्तासहितको निर्णय समर्थन प्लेटफर्म प्रस्ताव गर्दछौं । प्रणालीले बहुभाषिक, आवाजमा आधारित लक्षण क्याप्चर, पूर्वानुमानात्मक जोखिम स्तरीकरण र स्मार्ट रेफर सिफारिसहरू सक्षम बनाउँछ ।

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ह्युमन इन द लूप इन्टेलिजेन्सको सशक्तीकरण गर्दै प्लेटफर्मले उच्च जोखिमका केसहरू पहिले नै पत्ता लगाउन, रेफर ढिलाइलाई कम गर्न र कमसेवार समुदायमा मातृ र बाल स्वास्थ्य परिणामलाई सुधार गर्न सक्षम बनाउँछ ।

विद्यमान कार्यप्रवाहसँग मिल्दोजुल्दो मानव-इन-द-लुप निर्णय मोडललाई सहयोग गर्न जोखिम स्कोर र रेफर सिफारिस प्रदान गरिन्छ ।

मातृ र नवजात शिशुको जोखिम मूल्याङ्कनका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ताले सम्भावना देखाएको छ भने विद्यमान अधिकांश समाधान सुविधा केन्द्रित, कनेक्टिभिटीमा निर्भर वा पाइलट खटाउन मात्र सीमित छन् ।

अफलाइन फस्ट सिस्टम आर्किटेक्चरले कम कनेक्टिभिटी वातावरणमा कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्छ, कनेक्टिभिटी हुँदा सुरक्षित डेटा सिंक्रनाइजेसन हुन्छ ।

प्रस्तावित प्रणालीले पूर्वानुमानात्मक, सामुदायिक स्तरको ट्रायज गर्न सकिने, उच्च जोखिमका गर्भवती र बालरोगको प्रारम्भिक पहिचानमा सुधार हुने र समयमै र उचित हेरचाहको उकालोलाई मार्गदर्शन गर्दै रिफर ढिलाइ कम गर्ने व्यवस्था छ ।

एफसीएचभी नेतृत्वको मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सेवालाई अभिवृद्धि गर्न यस अध्ययनले एआई सहयोग निर्णय सहयोग ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ ।

राम राम्रो मान्छे हो ।	राम काठमाडौंमा बस्छन् ।
रामलाई सङ्गीत मन पर्छ ।	राम १३ वर्षका छन् ।
हिजो बाख्रा बिरामी थियो ।	रामलाई १०३ डिग्री ज्वरो आयो ।

https://www.linkedin.com/in/swastik-bhandari